



RUMAH SAKIT
PRIMA HUSADA

TERM OF REFERENCE (TOR)
PELATIHAN PENANGGULANGAN
KEBAKARAN (*CODE RED*)
DAN PENGGUNAAN APAR
RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA
TAHUN 2025

Jl. Banjararum Selatan No. 3-7 Mondoroko - Singosari, Malang

Telp. 0341-458679, 458916, Fax. 441874

Email : sekretariat@malang.rs-primahusada.com

www.rs-primahusada.com



TERM OF REFERENCE (TOR)

PELATIHAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN (CODE RED) DAN PENGUNAAN APAR RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA TAHUN 2025

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kebakaran adalah api yang tidak terkendali, tidak dikehendaki atau di luar kemampuan dan keinginan manusia yang dapat menimbulkan kerugian jiwa baik yang terbakar langsung maupun sebagai dampak dari suatu kebakaran, kerugian materi nilai aset atau bangunan terbakar, menurunnya produktivitas nasional maupun keluarga yang akan terganggu bahkan terhenti total, kerugian sosial mengalami hambatan yang berakibat turunya kesejahteraan masyarakat, gangguan bisnis arus barang terhenti total. Sedangkan bahaya kebakaran dapat ditimbulkan dengan adanya ancaman potensial berupa pancaran atau paparan api sejak proses awal kebakaran sampai menjalarnya api yang menimbulkan asap dan gas. Kebakaran disebabkan oleh faktor manusia dan faktor teknis (Ramli, 2010).

Di Rumah Sakit proses kegiatan keselamatan pasien merupakan hal yang wajib harus dilakukan. Keselamatan pasien adalah suatu sistem yang membuat asuhan pasien lebih aman, meliputi asesmen risiko, identifikasi dan pengelolaan risiko pasien, pelaporan dan analisis insiden, kemampuan belajar dari insiden dan tindak lanjutnya, serta implementasi solusi untuk meminimalkan timbulnya risiko dan mencegah terjadinya cedera yang disebabkan oleh kesalahan akibat melaksanakan suatu tindakan atau tidak mengambil tindakan yang seharusnya diambil (Permenkes, 2017). Sementara itu rumah sakit yang juga merupakan tempat kerja bagi tenaga kesehatan serta pelayanan kesehatan, tidak terlepas dari 1 2 kemungkinan-kemungkinan terjadinya suatu keadaan tanggap darurat, salah satunya adalah kemungkinan terjadinya yang dapat menimbulkan kerugian baik materi maupun kemungkinan adanya korban jiwa.

Rumah sakit merupakan salah satu tempat kerja yang memiliki risiko terhadap kebakaran. Hal ini dikarenakan, rumah sakit memiliki berbagai jenis bahan kimia yang mudah meledak, terbakar, serta peralatan elektronik yang dapat mengakibatkan terjadinya korsleting listrik (Saputra et al., 2019). Risiko kebakaran di rumah sakit menurut Perda Kota Surakarta No. 08 tahun 2019 termasuk ke dalam kategori ringan. Namun, hal itu tidak boleh disepelekan karena rumah sakit merupakan tempat yang di dalamnya berisi orang sakit yang kurang mampu secara fisik dan memiliki keterbatasan gerak dalam beraktivitas. Oleh karena itu, jika terjadi kebakaran di dalam rumah sakit, maka akan sangat membahayakan keselamatan pasien yang dirawat.

Dalam rangka pengamanan dari ancaman bahaya kebakaran, perlu diadakan pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran. Kebakaran bisa terjadi dalam waktu kapan saja, sehingga perlu kewaspadaan dalam mengatasi bahaya kebakaran tersebut (Ramli, 2010)

Penggunaan APAR pada awal mula terjadinya kebakaran merupakan alternatif untuk mencegah terjadinya kebakaran besar. APAR merupakan alat yang ringan serta mudah dilayani oleh satu orang untuk memadamkan api pada mula terjadinya kebakaran, pada saat api belum terlalu besar.

Salah satu upaya dalam penanganan kebakaran adalah dengan menggunakan Alat Pemadam Api Ringan (APAR) Adalah suatu alat berupa tabung yang diisi dengan media yang dapat mengatasi serta memadamkan kebakaran pada awal terjadinya api. Dalam apar masing masing memiliki berbagai macam variasi dan juga berbagai



macam isi tergantung dari golongan kebakaran yang terjadi dan apar yang di gunakan untuk penanggulangannya

B. Dasar Hukum

1. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor 186/Men/1999 Peraturan ini mengatur tentang pembentukan dan fungsi Unit Penanggulangan Kebakaran di tempat kerja.
2. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 26/PRT/M/2008 Peraturan ini mengatur tentang persyaratan teknis sistem proteksi kebakaran pada bangunan gedung dan lingkungan.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 Peraturan ini mengatur tentang standar kualifikasi aparaturnya pemadam kebakaran di daerah. Ini termasuk pelatihan, kompetensi, dan standar pakaian dinas bagi petugas pemadam kebakaran.
4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2009 Peraturan ini mengatur tentang pedoman teknis manajemen proteksi kebakaran di perkotaan. Ini termasuk perencanaan, pengendalian, dan penanganan kebakaran di tingkat perkotaan.
5. UU No. 1 tahun 1970 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Nomor 66 Tahun 2016 tentang Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Rumah Sakit.
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 26/PRT/M/2008 Tahun 2008 tentang Persyaratan Teknis Sistem Proteksi Kebakaran Pada Bangunan Gedung dan Lingkungan

C. Maksud dan Tujuan

1. Maksud
Karyawan dapat memahami penanggulangan bila terjadi kebakaran (Code Red) dan dapat menggunakan APAR secara langsung bila terjadi kedaruratan emergensi kebakaran (Code Red).
2. Tujuan
 - a. Karyawan siap siaga melakukan penanggulangan bila terjadi bencana kebakaran.
 - b. Karyawan paham alur penanggulangan bila terjadi bencana kebakaran
 - c. Karyawan tidak bingung saat menggunakan APAR.
 - d. Karyawan dapat menggunakan APAR sesuai langkah – langkahnya.

D. Indikator keberhasilan

1. Karyawan paham alur dan penanganan bila terjadi bencana kebakaran 100%.
2. Karyawan dapat menggunakan APAR secara baik 100%.



II. RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN

A. Susunan Panitia

NO	SUSUNAN PANITIA	NAMA	TUGAS
1	Ketua Panitia	Faisal Aminuddin Ilham, S.KM	Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan acara.
2	Sekretaris	Maheza Yudistiranti, S.AP	Bertanggung jawab terhadap pendokumentasian seluruh dokumen dan notulen
3	Keuangan	PT DPM	Bertanggung jawab terhadap anggaran dana Diklat
4	Sie Dokumentasi	Annadiva Fikri Chandra Maulana, S.Psi	Bertanggung jawab terhadap dokumentasi Diklat
5	Sie Penunjang	Erik Ardianata, M. Arifin, Annadiva Fikri Chandra Maulana, S.Psi	Bertanggung jawab mengkoordinir peserta untuk patuh dengan jadwal pelatihan.

B. Waktu Pelaksanaan

- Hari, Tanggal :
 - Senin, 09 Juni 2025
 - Selasa, 10 Juni 2025
- Pukul :
 - Gelombang 1 : 08.00-08.30 WIB (09/06/2025)
 - Gelombang 2 : 14.30-15.00 WIB (09/06/2025)
 - Gelombang 3 : 08.00-08.30 WIB (10/06/2025)
 - Gelombang 4 : 14.30-15.00 WIB (10/06/2025)
- Tempat : Hall Sakura Lantai 5 RS Prima Husada Malang

C. Rencana Rapat Panitia Penyelenggaraan

- Hari, Tanggal : Sabtu, 07 Juni 2025
- Pukul : 10.00 WIB
- Tempat : Kantor Lantai 5C

D. Sasaran atau Peserta

- Seluruh Staf RS Prima Husada

E. Susunan Acara Lengkap

NO	JAM	DURASI	MATERI	PETUGAS
Gelombang 1 & 3				
1	08.00-08.05 WIB	5 menit	Absensi dan Pretest	Annadiva Fikri Chandra Maulana, S.Psi
2	08.05-08.20 WIB	15 menit	Pemaparan Alur Penggulangan Kebakaran Rumah Sakit	Faisal Aminuddin Ilham, S.KM
3	08.20-08.30 WIB	10 menit	Praktek Menggunakan APAR dan post test	Annadiva Fikri Chandra Maulana, S.Psi
Gelombang 2 & 4				
1	14.30-14.35 WIB	5 menit	Absensi dan Pretest	Annadiva Fikri Chandra Maulana, S.Psi
2	14.35-14.50 WIB	15 menit	Pemaparan Alur Penggulangan Kebakaran Rumah Sakit	Faisal Aminuddin Ilham, S.KM



3	14.50-15.00 WIB	10 menit	Praktek Menggunakan APAR dan post test	Annadiva Fikri Chandra Maulana, S.Psi
---	-----------------	----------	--	---

F. Narasumber / Pemateri

1. Faisal Aminuddin Ilham, S.KM

G. Media

1. LCD
2. Laptop
3. Soeaker
4. Helm Bencana
5. APAR 3 Kg jenis powder

H. Metode

1. Ceramah
2. Diskusi
3. Roleplay
4. Tanya Jawab

I. Kebutuhan Anggaran

NO	KEBUTUHAN	JUMLAH	HARGA SATUAN	TOTAL
1	Fee untuk pemateri	1	Rp.0,-	Rp.0,-
2	Konsumsi pemateri dan panitia (nasi kotak & air mineral)	2	Rp.15.000,- / pack	Rp. 30.000
	Konsumsi peserta (air mineral)	3 dus / sesi = 12 dus	Rp.38.000,-	Rp.456.000,-
3	Sertifikat	Soft copy	Rp.0,-	Rp.0,-
Total Biaya				Rp.486.000,-

III. MONITORING – EVALUASI

1. Monitoring

- a. Monitoring dilakukan selama kegiatan berlangsung

2. Evaluasi

- b. Evaluasi diklat dilakukan oleh kepala ruang masing – masing dan disupervisi oleh Komite K3RS



IV. PENUTUP

Demikian TOR ini kami buat sebagai acuan dalam pelaksanaan pelatihan ini. Suksesnya acara ini memerlukan dukungan dan kerjasama dari seluruh staf yang ada dan agar tujuan orientasi tercapai sebagaimana yang diharapkan.

Malang, 15 Mei 2025
SDM RS Prima Husada

Ketua Panitia

Dokumen ditandatangani secara elektronik. Gunakan Pembaca Tandatangani Elektronik Untuk Verifikasi Dokumen Ini

Dokumen ditandatangani secara elektronik. Gunakan Pembaca Tandatangani Elektronik Untuk Verifikasi Dokumen Ini

**Annadiva Fikri Chandra
Maulana, S.Psi**

Faisal Aminuddin Ilham, S.KM

Menyetujui
Direktur RS Prima Husada



dr. Nur Mazidah